

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ: กล้องทำหัตถการ Covid-19

2. ผลงานประเภท: นวัตกรรม

3. คำสำคัญ: กล้องทำหัตถการ การแพร่กระจายเชื้อ Covid-19

4. สรุปผลงานโดยย่อ : เนื่องจากหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมใช้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (m9x) รับผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มาอนรักษาที่หอผู้ป่วย ซึ่งส่วนมากมักมีการทำหัตถการ เช่น การให้สารน้ำ การเจาะเลือด และทุกครั้งที่มีการทำหัตถการกับผู้ป่วยโควิด-19 พยาบาลจะต้องเข้าไปทำในห้อง Negative pressure ลำพังเพียงคนเดียว เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัด ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการทำหัตถการต่างๆ พยาบาลจะเตรียมชุดอุปกรณ์ใส่ถาดหรือถุงพลาสติกเข้าไปในห้องที่ผู้ป่วยนอน ซึ่งไม่สามารถเข็นรถหัตถการเข้าไปทำที่เตียง หรือนำผู้ป่วยเด็กมาทำที่ห้องหัตถการได้ เนื่องจากเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ หากมีอุปกรณ์ที่เลือกใช้จะต้องนำออกมาอบฆ่าเชื้อซ้ำๆ ก็จะทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ดังนั้นจึงต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พอดีกับการทำหัตถการ ส่วนมากอุปกรณ์มีชิ้นเล็ก มีจำนวนหลายชิ้น การใส่ถาดหรือถุงพลาสติกทำไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการหยิบใช้ บางครั้งเตรียมไม่ครบ/ไม่พอใช้ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ด้านนอกนอกห้องหยิบอุปกรณ์เพิ่ม ส่งผลให้การทำหัตถการล่าช้า เสี่ยงสัมผัสเชื้อจากเจ้าหน้าที่สู่เจ้าหน้าที่ และแพร่กระจายเชื้อในหอผู้ป่วยได้ง่าย เพื่อเป็นการลดการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเชื้อ ทางหอผู้ป่วยจึงได้จัดทำกล้องทำหัตถการสำหรับผู้ป่วย Covid-19 ขึ้น เพื่อนำไปไว้ในห้องผู้ป่วย ห้องละ 1 กล้อง ซึ่งจะนำอุปกรณ์ในการทำหัตถการ เช่น Syringe, IV catheter, Tube Lab, เข็ม เป็นต้นนำไปใส่ในกล่อง เมื่อมีรับใหม่หรือการทำหัตถการเจ้าหน้าที่สามารถหิ้วกล่องเข้าห้องไปในห้องผู้ป่วยสามารถเปิดใช้และทำหัตถการกับผู้ป่วยได้เลย โดยหลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ที่เข้าไปแล้วออกห้องผู้ป่วยให้น้อยที่สุด เติมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เสมอ และสะดวกต่อการหยิบใช้

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1. ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ Covid-19 ผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์
2. ลดปัญหาในการทำหัตถการล่าช้า อุปกรณ์ไม่พอใช้ขณะทำหัตถการ
3. เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการหยิบใช้

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

เนื่องจากหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรคใช้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (m9x) รับผู้ป่วย Covid-19 มาอนรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรคติดต่อ ต้องอยู่ห้องแยกโรคที่มีความดันลบ จึงมีข้อจำกัดในการเข้าไปทำหัตถการกับผู้ป่วย เมื่อแพทย์มี order ให้ทำหัตถการ เช่น ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เจาะเลือด On Heparin lock และการทำหัตถการอื่นๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลจะต้องเข้าไปทำหัตถการคนเดียว เพื่อเป็นการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จะเสี่ยงสัมผัสเชื้อมากขึ้น และในการทำหัตถการแต่ละครั้งจะต้องเตรียมชุดอุปกรณ์ เข้าไปทำหัตถการในห้อง Negative pressure สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อ covid-19 ก็จะเข็นรถหัตถการเข้าไปทำที่เตียง หรือนำผู้ป่วยเด็กมาทำที่ห้องหัตถการ แต่กรณีผู้ป่วย Covid-19 จะไม่สามารถนำรถหัตถการเข้าไปในห้องผู้ป่วยได้ เนื่องจากเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อกับรถหัตถการและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้ และถ้าต้องเอาอุปกรณ์ที่เลือกใช้หรือใช้ไม่หมด ออกมาอบฆ่าเชื้อซ้ำๆ ก็จะทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพ จึงต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้พอดีกับที่จะทำหัตถการ และอุปกรณ์มีชิ้นเล็ก จำนวนหลายชิ้น การใส่ถาดหรือถุงพลาสติกเข้าไปทำให้ไม่เป็นระเบียบ ไม่สะดวกต่อการหยิบใช้ บางครั้งเอาอุปกรณ์เข้าไปไม่พอใช้ ไม่ครบ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องหยิบอุปกรณ์เพิ่มเติม ส่งผลให้การทำหัตถการล่าช้า เจ้าหน้าที่ด้านนอกทำงานเอกสารไม่ทัน เสี่ยงสัมผัสเชื้อจากเจ้าหน้าที่สู่เจ้าหน้าที่ และถ้าหากอุปกรณ์เหลือ ต้องนำออกมาข้างนอกห้องเพื่ออบฆ่าเชื้อ เป็นการเสี่ยงต่อการปนเปื้อน และแพร่กระจายเชื้อในหอผู้ป่วยได้ง่าย เพื่อเป็นการลดการสัมผัสเชื้อ ลดการแพร่กระจายเชื้อ ทางหอผู้ป่วยจึง

ได้จัดทำกล่องทำหัตถการ Covid-19 ขึ้น เพื่อไว้ในห้องผู้ป่วย ห้องละ1กล่อง ซึ่งจะนำอุปกรณ์ในการทำหัตถการ เช่น Syring, IV catheter, Tube Lab, เข็ม เป็นต้น นำไปใส่ในกล่องดังกล่าว จัดให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการหยิบใช้ และเมื่อมีการทำหัตถการเจ้าหน้าที่สามารถหิ้วกล่องดังกล่าวเข้าห้องผู้ป่วยได้ทันที เปิดใช้ และทำหัตถการกับผู้ป่วยได้เลย หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์เข้าหรือออกห้องผู้ป่วยให้น้อยที่สุด และจะมีการส่งเวรบอกต่อว่าอุปกรณ์ใดที่ต้องเติมเพิ่มกับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปทำหัตถการครั้งต่อไป เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เสมอ

7. กิจกรรมพัฒนา

1. ระดมความคิด ในการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ที่ต้องเข้าไปทำหัตถการในห้องผู้ป่วย
2. นำกล่องพลาสติกที่มีฝาปิด มีหูหิ้ว ขนาดพอเหมาะมือ หิ้วสะดวก
3. ทำที่กั้นเป็นช่องๆภายในกล่องโดยใช้กระดาษแข็ง เพื่อแบ่งแยกอุปกรณ์ไม่ให้ปนกัน
4. เขียนระบุว่า “กล่องอุปกรณ์หัตถการ สำหรับเจ้าหน้าที่”
5. นำอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการต่างๆ บรรจุไว้ในกล่องปริมาณพอดี
6. นำไปวางไว้ในห้องผู้ป่วย Covid-19 ห้องละ 1 กล่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พร้อมหยิบใช้ และไม่นำออกนอกห้อง เติมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เสมอ รวมทั้งตรวจสอบความหมดอายุ
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม 2569 – เมษายน 2569

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จความสำเร็จที่สำคัญ

1. เจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการหยิบใช้อุปกรณ์
2. สามารถทำหัตถการ ให้การรักษายาบาลผู้ป่วยได้รวดเร็วมากขึ้น
3. ลดการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเชื้อ จากการหยิบจับอุปกรณ์ออกนอกห้องผู้ป่วย
4. อุปกรณ์ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน ไม่เสื่อมสภาพจากการอบฆ่าเชื้อ
5. เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกมีเวลาปฏิบัติงานได้เต็มที่ ไม่เสียเวลาส่งอุปกรณ์ที่ขาดให้กับเจ้าหน้าที่ในห้องผู้ป่วยบ่อยครั้ง

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

1. ประเมินความพึงพอใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการใช้กล่องหัตถการเป็นระยะๆ ทุก 3-6 เดือน
2. เจ้าหน้าที่สามารถหยิบใช้อุปกรณ์ เพื่อทำหัตถการได้สะดวก รวดเร็ว และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจากอุปกรณ์ ส่นอกห้องให้น้อยที่สุด

10. บทเรียนที่ได้รับ

1. อุปกรณ์ในกล่องหัตถการที่นำไปวางไว้ในห้องผู้ป่วย Covid-19 พบหมดอายุ เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุอย่างสม่ำเสมอ
2. การนำวัสดุมาดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ ช่วยในการทำงานสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงานได้ พร้อมทั้งยอมรับข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวผาณิตา ปานเงิน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ |
| 2. นางสาวอนงค์พร สงวนสัตย์ | ผู้ช่วยพยาบาล |
| 3. นางสาวประเทือง บำรุงเมือง | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ |

ตึกกุมารเวชกรรมใช้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ม9ข) โทร 3904 M9b.nursing@gmail.com

ขั้นตอนการประดิษฐ์กล่องทำหัตถการ Covid-19